

Documento generado por MARU OS a partir de la base de conocimiento offline.
Fuentes etiquetadas honestamente (resúmenes MARU basados en normas/guias).
No sustituye asesoría médica, legal o de emergencia profesional.

1. Dengue: diagnóstico y manejo clínico (MINSA)

Fuente: NTS N° 125-MINSA/2016/CDC-DGIESP - Norma Técnica de Salud para la vigilancia y atención de casos de dengue

Agentes: aya, tupac

El dengue es una arbovirosis transmitida por el zancudo *Aedes aegypti*. Cuadro típico: fiebre alta (2-7 días), cefalea, dolor retroocular, mialgias, artralgias, erupción cutánea. Signos de alarma (requieren atención inmediata): dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, letargia o irritabilidad, acumulación de líquidos, hepatomegalia >2 cm, aumento del hematocrito con caída rápida de plaquetas. **REGLA CRÍTICA DE SEGURIDAD:** en caso de dengue probable o confirmado está **PROHIBIDO** usar AINEs (ibuprofeno, naproxeno), aspirina (ácido acetilsalicílico) o corticoides, porque aumentan el riesgo de sangrado y gastritis hemorrágica. El único antipirético/analgésico indicado es **PARACETAMOL** (adultos: 500 mg - 1 g cada 6 horas, max. 4 g/día). No se usan antibióticos ni antivirales específicos. Manejo grupo A (sin signos de alarma): hidratación oral abundante, paracetamol, reposo, control diario y búsqueda activa de signos de alarma. Grupo B (con signos de alarma o comorbilidad): observación/hospitalización con hidratación endovenosa. Grupo C (dengue grave): emergencia - choque, sangrado grave o daño de órganos; manejo en UCI. Prevención: eliminar criaderos (recipientes con agua), uso de repelente y ropa de manga larga. Ante sospecha, acudir al establecimiento de salud más cercano; no automedicarse.

2. Anemia infantil y gestacional: prevención y tratamiento (MINSA)

Fuente: NTS N° 134-MINSA/2017/DGIESP - Norma Técnica para el manejo terapéutico y preventivo de la anemia en niños

Agentes: aya, sumaq

La anemia por deficiencia de hierro se diagnostica con hemoglobina: en niños de 6-59 meses <11.0 g/dL; en gestantes (1er y 3er trimestre) <11.0 g/dL. Los valores se ajustan por altitud (a mayor altura, el punto de corte sube). Tratamiento en niños de 6 meses a 11 años con anemia: hierro a dosis de 3 mg/kg/día (sulfato ferroso o complejo polimaltosado) durante 6 meses continuos, con control de hemoglobina al mes, a los 3 y a los 6 meses. Prevención en niños de 4-35 meses: suplementación con hierro en gotas/jarabe o micronutrientes en polvo ('chispitas'). Gestantes: suplementación preventiva con hierro (60 mg de hierro elemental) + ácido fólico (400 µg) desde la semana 14 hasta 30 días posparto; si hay anemia, dosis terapéutica de 120 mg de hierro elemental/día y control prenatal reforzado. Recomendaciones dietéticas oficiales: consumir alimentos ricos en hierro hemínico - sangrecita, bazo, hígado, carnes rojas, pescado oscuro - acompañados de vitamina C (cítricos) para mejorar absorción; evitar tomar el hierro junto con té, café o lácteos, que inhiben su absorción. El tamizaje y el suplemento se entregan gratuitamente en los establecimientos de salud MINSA.

3. Tuberculosis sensible y MDR: atención integral (MINSA)

Fuente: NTS N° 104-MINSA/DGSP-V.01 - Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas por

Agentes: aya

Sintomático respiratorio: toda persona con tos con flema por 15 días o más debe recibir evaluación gratuita con baciloscopia de esputo en cualquier establecimiento de salud.

Diagnostico: baciloscopia, cultivo y pruebas de sensibilidad rapida (para detectar resistencia a isoniacida y rifampicina). TBC sensible - Esquema para adultos: 2 meses de fase intensiva con isoniacida (H), rifampicina (R), pirazinamida (Z) y etambutol (E) en dosis diaria, seguidos de 4 meses de fase de continuacion con isoniacida y rifampicina (2HRZE/4H3R3 segun norma). El tratamiento es GRATUITO y estrictamente supervisado (DOT: el personal de salud observa la toma de cada dosis). TBC MDR (multidrogorresistente, resistente al menos a isoniacida y rifampicina): requiere esquemas individualizados mas prolongados con farmacos de segunda linea (p. ej. levofloxacino, bedaquilina, linezolid), aprobados por el Comit  Regional/Nacional de Evaluacion de Retratamientos. Nunca abandonar el tratamiento: el abandono genera resistencia. Se debe estudiar a los contactos del hogar. Medidas de control: ventilacion de ambientes, cubrirse al toser, y quimioprofilaxis con isoniacida en contactos menores de 5 anos segun evaluacion medica.

4. Diabetes mellitus tipo 2: diagnostico y tratamiento (MINSa)

Fuente: Guia de Practica Clinica para el Diagnostico, Tratamiento y Control de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de

Agentes: aya, sumaq

Diagnostico de diabetes tipo 2 (cualquiera de los criterios): glucemia en ayunas ≥ 126 mg/dL (en dos ocasiones), glucemia ≥ 200 mg/dL a las 2 horas de una carga oral de 75 g de glucosa, HbA1c ≥ 6.5 %, o glucemia al azar ≥ 200 mg/dL con sintomas clasicos (poliuria, polidipsia, perdida de peso). Tratamiento de primera linea: cambios en el estilo de vida (alimentacion saludable, reduccion de azuc res simples, actividad fisica ≥ 150 min/semana, control de peso) + METFORMINA como farmaco inicial de eleccion, comenzando con dosis bajas junto a las comidas para reducir molestias gastrointestinales. Si no se alcanza la meta, se anade una sulfonilurea u otro agente, y se considera insulina cuando hay hiperglucemia marcada o falla del tratamiento oral. Meta de control general: HbA1c < 7 % (individualizar en adultos mayores). Control periodico de presion arterial, perfil lipidico, funcion renal (creatinina, microalbuminuria), examen de pies (prevencion de pie diabetic ) y fondo de ojo anual. Signos de alarma para acudir de inmediato a un establecimiento de salud: glucemias muy altas con vomitos o deshidratacion, heridas en pies que no cicatrizan, o sintomas de hipoglucemia severa (sudoracion, temblor, confusion) en usuarios de insulina o sulfonilureas.

5. Hipertension arterial: diagnostico, tratamiento y control (MINSa)

Fuente: Guia de Practica Clinica N   045: Diagnostico, Tratamiento y Control de la Enfermedad Hipertensiva (RM N   031)

Agentes: aya

Diagnostico: presion arterial (PA) $\geq 140/90$ mmHg confirmada en al menos dos mediciones correctas en dos visitas distintas (paciente sentado, en reposo ≥ 5 minutos, sin cafe ni tabaco previos). Tratamiento no farmacologico (para todos): reducir el consumo de sal a menos de 5 g/dia, dieta rica en frutas y verduras, actividad fisica regular (≥ 150 min/semana), mantener peso saludable, no fumar y moderar el alcohol. Tratamiento farmacologico de primera linea disponible en el primer nivel de atencion: inhibidores de la ECA (enalapril) o antagonistas de los receptores de angiotensina II (losartan); como alternativas, diureticos tiazidicos o calcioantagonistas (amlodipino), solos o combinados segun respuesta y comorbilidad. Meta general: PA $< 140/90$ mmHg (mas estricta en pacientes con diabetes o enfermedad renal segun evaluacion medica). Crisis hipertensiva (PA $\geq 180/110$ -120 mmHg): si hay sintomas como dolor toracico, dificultad respiratoria, deficit neurologico o vision borrosa, es una EMERGENCIA - llamar al SAMU 106 o acudir de inmediato al establecimiento de salud. El tratamiento es de por vida y no debe suspenderse sin indicacion medica.

6. Mal agudo de montaña (soroche): prevención y manejo

Fuente: MINSA - recomendaciones oficiales de salud del viajero a altura; consenso internacional (Lake Louise Score) para mal

Agentes: aya, yaku

El mal agudo de montaña (soroche) aparece típicamente sobre los 2,500 m s. n. m. (Cusco 3,399 m, Puno 3,827 m, Huaraz 3,052 m) por menor presión parcial de oxígeno. Síntomas: cefalea, náuseas, mareo, fatiga, insomnio, falta de apetito; suele iniciar entre 6 y 12 horas tras el ascenso. Prevención: ascenso gradual (idealmente pernoctar a altura intermedia), evitar esfuerzos intensos y alcohol las primeras 24-48 horas, hidratarse bien y comer ligero. El mate o la hoja de coca son de uso tradicional para aliviar síntomas leves. En personas con antecedentes o ascensos rápidos, el médico puede indicar acetazolamida preventiva (125-250 mg cada 12 h iniciando el día previo al ascenso); contraindicada en alérgicos a sulfas. Manejo de síntomas leves: reposo, hidratación, analgésicos simples (paracetamol) y no seguir ascendiendo hasta mejorar. SIGNOS DE GRAVEDAD (edema cerebral o pulmonar de altura): dificultad respiratoria en reposo, tos con esputo espumoso o rosado, confusión, marcha inestable o somnolencia extrema - es una emergencia: administrar oxígeno si está disponible y DESCENDER de inmediato al menos 500-1,000 m, y llamar al SAMU 106. Personas con cardiopatía, EPOC o anemia severa deben consultar al médico antes de viajar a altura.

7. COVID-19: prevención, manejo y signos de alarma

Fuente: MINSA - documentos técnicos de manejo de COVID-19 en el Perú (RM N° 834-2021/MINSA y actualizaciones); re

Agentes: aya

El COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2 y se transmite principalmente por vía respiratoria (aerosoles y gotículas). Síntomas frecuentes: fiebre, tos, dolor de garganta, malestar general, cefalea, pérdida de olfato o gusto. El diagnóstico se confirma con prueba de antígeno o RT-PCR. Manejo de casos leves (la mayoría): aislamiento domiciliario, reposo, hidratación abundante y paracetamol para fiebre o malestar. NO están indicados antibióticos de rutina, ivermectina ni hidroxiquina (sin evidencia de beneficio según MINSA/OMS). Monitorizar la saturación de oxígeno con pulsioxímetro si está disponible. SIGNOS DE ALARMA - acudir de inmediato a un establecimiento de salud o llamar al 113 (línea MINSA) / SAMU 106: dificultad para respirar, saturación de oxígeno menor a 94 %, dolor u opresión persistente en el pecho, confusión o labios/cara azulados. Prevención: vacunación completa y refuerzos según esquema vigente del MINSA (gratuita), ventilación de ambientes cerrados, lavado de manos y uso de mascarilla en entornos de riesgo o con síntomas respiratorios. Grupos de riesgo (adultos mayores, gestantes, inmunosuprimidos, enfermedades crónicas) deben consultar precozmente ante síntomas.

8. RCP básico en adultos (reanimación cardiopulmonar)

Fuente: Guías AHA 2020 de RCP básico (soporte vital básico), adoptadas por MINSA/SAMU - Emergencias: SAMU 106, Bom

Agentes: aya, tupac

Cadena de supervivencia ante un adulto que no responde y no respira (o solo jadea/boquea):

- 1) Verificar seguridad de la escena.
- 2) Comprobar respuesta (hablarle, estimular hombros).
- 3) LLAMAR AL SAMU 106 (o Bomberos 116) y pedir un DEA (desfibrilador externo automático) si hay alguno cerca.
- 4) Iniciar compresiones torácicas de inmediato: centro del pecho (mitad inferior del esternón), con el talón de una mano y la otra encima, brazos rectos; profundidad de 5-6 cm; frecuencia de 100 a 120 compresiones por minuto; permitir la reexpansión completa del tórax entre compresiones y minimizar interrupciones.
- 5) Si esta

entrenado: 30 compresiones y 2 ventilaciones (30:2). Si no está entrenado o no puede ventilar, hacer RCP solo con las manos (compresiones continuas) - también salva vidas. 6) En cuanto llegue el DEA, encenderlo y seguir sus instrucciones de voz: descarga si la indica y reanudar compresiones inmediatamente después. No detener la RCP hasta que la persona respire o se mueva, llegue ayuda profesional, o el rescatista esté exhausto. En posible sobredosis o ahogamiento, las ventilaciones son especialmente importantes.

9. Atragantamiento: maniobra de Heimlich (compresiones abdominales)

Fuente: Guías AHA/Cruz Roja de primeros auxilios para obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño - Emergencias: SAMU

Agentes: aya, tupa

Obstrucción LEVE (la persona puede toser o hablar): animarla a seguir tosiendo con fuerza; no dar golpes ni maniobras todavía; vigilar de cerca. Obstrucción GRAVE en adulto o niño mayor de 1 año (no puede hablar, toser ni respirar; se lleva las manos al cuello): pedir que alguien llame al SAMU 106 y actuar de inmediato con la maniobra de Heimlich: colocarse detrás de la persona, rodear su cintura con los brazos, poner un puño con el pulgar hacia adentro justo por encima del ombligo (debajo del esternón), sujetar el puño con la otra mano y realizar compresiones bruscas hacia adentro y hacia arriba, repitiendo hasta que expulse el objeto o pierda el conocimiento. Alternativa recomendada: alternar 5 golpes secos entre los omoplatos con 5 compresiones abdominales. En gestantes o personas con obesidad: compresiones en el centro del pecho (torácicas), no abdominales. En bebés menores de 1 año: NO hacer Heimlich; sostener al bebé boca abajo sobre el antebrazo y dar 5 golpes entre los omoplatos, luego voltear y dar 5 compresiones torácicas con dos dedos, alternando. Si la persona queda inconsciente: bajarla al suelo con cuidado e iniciar RCP, revisando la boca antes de cada ventilación.

10. Mordedura de araña casera (Loxosceles laeta) y suero antiloxoscelico

Fuente: MINSA / Instituto Nacional de Salud (INS) - Norma y manejo de loxoscelismo en el Perú; el INS produce el suero antiloxoscelico

Agentes: aya, tupa

La araña casera *Loxosceles laeta* ('araña violinista' o 'violonchista') vive dentro de las casas peruanas: rincones oscuros, detrás de cuadros y muebles, en ropa y zapatos guardados. Su mordedura causa loxoscelismo, una emergencia médica. Formas clínicas: CUTANEA (la más frecuente, ~85 %): dolor creciente, enrojecimiento y una placa violácea ('placa livedoide') que puede evolucionar a necrosis de la piel en 24-72 horas. CUTANEO-VISCERAL (grave, ~15 %): además, en las primeras 24-48 h aparecen orina oscura (color coca-cola), ictericia, fiebre y anemia por hemólisis; puede causar falla renal y muerte. Primeros auxilios: lavar la zona con agua y jabón, aplicar frío local, retirar anillos/pulseras, NO cortar, NO succionar, NO aplicar torniquetes ni emplastos, y si es posible capturar la araña (incluso aplastada) para identificación. ACUDIR DE INMEDIATO al establecimiento de salud u hospital - llamar al SAMU 106 si es grave. Tratamiento específico: SUERO ANTILOXOSCELICO producido por el Instituto Nacional de Salud (INS), más eficaz dentro de las primeras horas tras la mordedura; disponible en hospitales de referencia. Vigilar el color de la orina las primeras 48 horas. Prevención: sacudir ropa, zapatos y camas antes de usarlos, limpiar detrás de muebles y cuadros.

11. Plan de evacuación por huaico o deslizamiento (INDECI)

Fuente: INDECI - recomendaciones oficiales ante huaicos y deslizamientos (Plan Familiar de Emergencia) - Emergencias: IND

Agentes: tupa, aya, pacha

ANTES (preparación): identificar con la familia las zonas seguras y rutas de evacuación

senalizadas por el municipio/INDECI (partes altas, alejadas del cauce de quebradas y rios). Preparar la MOCHILA DE EMERGENCIA: agua (2 L por persona), alimentos no perecibles, linterna, radio a pilas, botiquin, medicamentos personales, copia de documentos (DNI), abrigo, silbato y efectivo. Acordar un punto de reunion familiar. En temporada de lluvias (diciembre-abril, especialmente en quebradas como las de Chosica), estar atentos a las alertas de SENAMHI e INDECI. DURANTE: al escuchar la alarma o un ruido creciente desde la quebrada (piedras, agua), EVACUAR DE INMEDIATO hacia las zonas altas por las rutas establecidas, sin regresar por pertenencias. Nunca cruzar el cauce ni intentar atravesar el flujo de lodo a pie o en vehiculo. Alejarse de postes y cables electricos. DESPUES: permanecer en la zona segura hasta el anuncio oficial; no ingresar a viviendas afectadas hasta su evaluacion; hervir o desinfectar el agua antes de consumirla; reportar personas heridas o atrapadas. Numeros de emergencia: INDECI/COEN 115, Bomberos 116, SAMU 106, Policia Nacional 105.

12. Constitucion Politica del Peru: dignidad, derechos, salud (Arts. 1, 2, 7, 9)

Fuente: Constitucion Politica del Peru (1993) - Articulos 1, 2, 7 y 9

Agentes: yaku, inti

Articulo 1: 'La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.' Articulo 2 (derechos fundamentales de la persona, seleccion): toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psiquica y fisica y a su libre desarrollo y bienestar (inc. 1); a la igualdad ante la ley, sin discriminacion por origen, raza, sexo, idioma, religion, opinion, condicion economica o de cualquier otra indole (inc. 2); a la libertad de conciencia y de religion (inc. 3); a las libertades de informacion, opinion, expresion y difusion (inc. 4); y a que los servicios informaticos no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar (inc. 6). Articulo 7: 'Todos tienen derecho a la proteccion de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, asi como el deber de contribuir a su promocion y defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia fisica o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un regimen legal de proteccion, atencion, readaptacion y seguridad.' Articulo 9: 'El Estado determina la politica nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicacion. Es responsable de disenarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud.'

13. Ley General de Salud N° 26842: emergencia obligatoria y consentimiento informado

Fuente: Ley N° 26842, Ley General de Salud (1997) - Arts. 3 (modif. por Ley N° 27604), 4, 15 y 25

Agentes: yaku, inti, aya

ATENCION DE EMERGENCIA OBLIGATORIA (Art. 3, modificado por Ley N° 27604): toda persona tiene derecho a recibir atencion medico-quirurgica de emergencia en cualquier establecimiento de salud, publico o privado, cuando este en riesgo grave su vida o su salud. Ningun establecimiento puede negar la atencion de emergencia ni condicionarla a pago previo, garantia o tramite administrativo mientras subsista el estado grave de riesgo.

CONSENTIMIENTO INFORMADO (Art. 4): ninguna persona puede ser sometida a tratamiento medico o quirurgico sin su consentimiento previo, o el de la persona llamada legalmente a darlo. Se exceptuan las intervenciones de emergencia. DERECHOS DEL USUARIO (Art. 15): toda persona usuaria de los servicios de salud tiene derecho, entre otros, al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad; a exigir la reserva de la informacion relacionada con el acto medico y su historia clinica; a no ser objeto de experimentacion sin su consentimiento; a que se le

brinde informacion veraz, oportuna y completa sobre su diagnostico, tratamiento, riesgos y alternativas; y a negarse a recibir o continuar un tratamiento (con las excepciones de ley).
CONFIDENCIALIDAD (Art. 25): la informacion sobre el acto medico es reservada; el profesional y el establecimiento estan obligados a guardar esa reserva, con excepciones tasadas por ley (orden judicial, vigilancia epidemiologica, etc.).

14. Ley N° 29733 de Proteccion de Datos Personales: datos de salud como sensibles

Fuente: Ley N° 29733, Ley de Proteccion de Datos Personales (2011) y su Reglamento (D.S. N° 003-2013-JUS; actualiz.

Agentes: yaku, inti, kipu

La Ley N° 29733 desarrolla el derecho fundamental a la proteccion de los datos personales (Constitucion, Art. 2 inc. 6). Se aplica a todo tratamiento de datos en bancos de datos publicos o privados. DATOS SENSIBLES: la ley califica como datos sensibles, entre otros, los datos de SALUD (fisica o mental), datos biometricos, origen racial y etnico, opiniones politicas, convicciones religiosas, y vida u orientacion sexual. Su tratamiento exige CONSENTIMIENTO previo, expreso, informado, inequivoco y POR ESCRITO (o medio equivalente) del titular, salvo excepciones legales (p. ej., atencion medica de emergencia o razones de salud publica previstas por ley). Principios rectores: legalidad, consentimiento, finalidad (los datos solo se usan para el fin informado), proporcionalidad, calidad, seguridad (medidas tecnicas y organizativas adecuadas) y disposicion de recurso. Derechos del titular (derechos 'ARCO'): Acceso a sus datos, Rectificacion, Cancelacion (supresion) y Oposicion al tratamiento. Se ejercen gratuitamente ante el titular del banco de datos; en caso de negativa, cabe reclamo ante la Autoridad Nacional de Proteccion de Datos Personales (Ministerio de Justicia) o proceso de habeas data. Implicancia practica para MARU OS: el perfil de salud del usuario (alergias, medicamentos, condiciones) es dato sensible - debe procesarse localmente, con consentimiento y sin compartirse con terceros.